

Normalità e Patologia nell'Età Evolutiva

I Tempi della Vita · Sessione 08

Questa lezione è una bussola per capire quando un bambino o un adolescente sta semplicemente attraversando la fatica di crescere — e quando invece c'è qualcosa che ha bisogno di cura. Non è mai semplice come sembra, ma esistono strumenti per orientarsi. Docente: Mattia Antonini, psicologo e psicoterapeuta.

Il problema della normalità: quattro modi di guardarla

Prima di parlare di patologia, dobbiamo capire cos'è la **normalità**. E qui arriva già il primo colpo di scena: non esiste una definizione unica. Marcelli (1999) individua quattro punti di vista, ognuno con i suoi limiti:

Definizione	In parole semplici	Il problema
Media statistica	Normale = chi rientra nella media misurata (es. QI 85-115, BMI 18,5-24,9)	È descrittiva, quantitativa. Non dice nulla sulla qualità della vita o sulla sofferenza
Ideale a cui avvicinarsi	Normale = il bambino "perfetto" secondo le aspettative di genitori, scuola, società	È un costrutto sociale. Chi definisce l'ideale?
Processo dinamico	Normale = chi si adatta, è resiliente, torna all'equilibrio dopo le difficoltà	Presuppone che tutti abbiano le stesse risorse per farcela

Definizione	In parole semplici	Il problema
Assenza di malattia	Normale = non malato	Circolare. Definisce la normalità per esclusione

La **norma statistica** è quella più usata in clinica. Strumenti come ADOS-2 (autismo), WISC-V (cognitivo), CBCL (comportamento), Conners 3 (ADHD) confrontano il singolo con la media della popolazione. Sono utili — aiutano a superare i bias clinici (es. confondere ansia con un limite cognitivo) e garantiscono anche coperture assicurative — ma possono diventare pericolosi se usati male. Il rischio è **crystallizzare una persona in un punteggio**, trattando un valore numerico come un confine rigido tra "normale" e "patologico".

Il sintomo: non è il nemico che sembra

Qui il prof introduce una distinzione fondamentale che devi avere chiara all'esame.

Sintomo (dal greco *syn* = insieme, *pipto* = cadere): è qualcosa che "cade insieme" ad altri segnali. In psicoanalisi, è un **compromesso** — tra pulsione e difesa, tra richieste dell'ambiente e salvaguardia di sé. Il sintomo **rappresenta un tentativo di guarigione** e un **tentativo di narrazione** (a volte raffinato, a volte molto primitivo).

In medicina, tecnicamente: - **Sintomo** = manifestazione soggettiva riferita dal paziente - **Segno** = fenomeno oggettivo, misurabile, osservabile dall'esterno

Da un sintomo si può arrivare a diagnosi molto diverse. Esempio: - "Non ho mai voglia di alzarmi dal letto" → clinofilia depressiva? disturbo del sonno? ritiro psicotico? - "Mi pare di *flaskare*, la realtà diventa come un film" → derealizzazione? abuso di sostanze? esordio psicotico?

Il sintomo nel bambino sano

Citando **D.W. Winnicott**, il prof dice una cosa contro-intuitiva ma potente:

Un bambino sano può manifestare un repertorio flessibile di sintomi.
L'assenza di qualsiasi sintomo nel bambino è un evento raro — in alcuni casi è un conformismo adattivo, un "falso sé".

Pensa a una pianta: le foglie che cadono in autunno non sono un problema, fanno parte del ciclo. Il problema è se la pianta perde le foglie in piena estate, sempre nello stesso modo, senza poter fare altro. La **rigidità** è il vero segnale patologico, non il sintomo in sé.

La **patologia** si manifesta come **limitazione e rigidità**: i sintomi non fanno più il loro lavoro, non traghettano il bambino oltre la difficoltà, diventano solo un disturbo per lui e per il suo ambiente.

Il sintomo come linguaggio (e come richiesta)

Il sintomo in età evolutiva ha tre funzioni: 1. Cerca un'organizzazione interna più adattativa 2. È una **richiesta verso i caregiver** — es. alterazioni del sonno, dell'alimentazione, del controllo sfinterico possono essere rivendicazioni verso un ambiente di accudimento sentito come insufficiente 3. Cerca un significato quando livelli di simbolizzazione più maturi sono inaccessibili

I sintomi **nelle fasi di transizione** meritano attenzione speciale: appaiono spesso quando una fase di sviluppo fa richieste insolitamente elevate alla personalità del bambino. Il sintomo può aiutare transitoriamente a organizzare l'affettività, traghettando il bambino oltre il periodo difficile.

La conclusione pratica: - I sintomi vanno **ascoltati e interpretati** (hanno valore evolutivo) - I sintomi segnalano anche **problemi seri** (psicopatologia, sofferenza, disarmonie di sviluppo)

Quindi vanno sia accolti che curati — non è una contraddizione, è la doppia natura del sintomo.

Perché la psicologia non è come la medicina: due difficoltà enormi

Due problemi specifici rendono la valutazione psicologica di bambini e adolescenti particolarmente complessa:

1. **Assenza di markers biologici** — non esiste un esame del sangue per diagnosticare l'ansia o la depressione. Non c'è un antigene che dice "questo bambino ha un disturbo".
2. **Assenza di sintomi patognomonic** — non esistono sintomi specifici di una sola malattia. L'ansia si trova in quasi tutti i disturbi psichiatrici. L'**anedonia** (assenza di interesse per attività piacevoli) può essere normale adolescenza, depressione, o forma psicotica. Le dispercezioni possono indicare esordio psicotico, abuso di sostanze, o disturbo del sonno.

In più, tendiamo a **sovrastimare i sintomi "rumorosi"** (positivi: aggressività, deliri circoscritti, scariche agite) e a ignorare i **sintomi silenziosi** (negativi: calo delle funzioni cognitive, diminuzione della spinta vitale). Le psicosi più gravi possono avere un esordio lento e insidioso. Bisogna sviluppare un ascolto per i silenzi, i vuoti, quello che manca.

Dato importante: il **75-90% delle esperienze psicotiche subcliniche** sono transitorie e scompaiono con la maturazione (tasso di prevalenza clinica ~5%). Tuttavia, l'esposizione a rischio ambientale elevato può renderle persistenti e clinicamente rilevanti.

La **maturazione psicologica e neuronale** è un alleato potente: migliora il controllo emotivo, riduce la spinta ad agire, sviluppa la funzione riflessiva, aumenta la connettività neuronale (grazie al *pruning* — la potatura sinaptica).

I quattro assi della valutazione: come si legge un bambino

La sintomatologia in età evolutiva è troppo instabile per essere l'unica base di valutazione. Serve una **valutazione quadrupla** su quattro assi:

Asse 1 — Sindromico-Sintomatico

Raccoglie e organizza i sintomi, li trasforma in segni, formula ipotesi diagnostiche.

Aree da esplorare: - **Area del corpo:** sfera oro-alimentare, addormentamento e sonno, controllo sfinterico, condotte sessuali, condotte motorie - **Area del comportamento:** alterazioni comportamentali, condotte aggressive, affettività, funzioni cognitive, linguaggio, regolazione/strumentalità

Asse 2 — Strutturale

Va al di là dei sintomi e cerca l'**organizzazione profonda del mondo psichico**. Stessa sintomatologia può corrispondere a strutture psichiche molto diverse (nevrotica, psicotica, borderline).

Tre griglie diagnostiche di riferimento:

Jean Bergeret (1974 — *La personalità normale e patologica*): strutturalista psicoanalitico puro. La sua griglia si basa su 4 criteri: sintomi, difese, tipo di angoscia, relazione d'oggetto.

Otto Kernberg (1984 — *Disturbi gravi della personalità*): stessa tripartizione nevrotico/ borderline/psicotico, con criteri formali. La sua griglia: sintomi, integrazione vs dispersione dell'identità, difese, esame della realtà.

Palacio Espasa e Dufour — griglia specifica per l'**età evolutiva**: impressione generale, relazione con l'esaminatore, funzioni dell'Io (motricità, intelligenza, linguaggio, esame di realtà, flusso del pensiero), affetti, meccanismi di difesa, espressione pulsioni e fantasmi, Super-Io e Ideale dell'Io, immagine di sé e identificazioni.

Un disturbo alimentare può essere espressione di un disagio nevrotico, psicotico o limite. Un'encopresi può manifestarsi in un bambino con funzionamento autistico così come rappresentare un sintomo reattivo in un bambino nevrotico in un momento di sofferenza.

La domanda chiave dell'asse strutturale: la condotta sintomatica è **in relazione** con il movimento maturativo, oppure è un **ostacolo** all'evoluzione maturativa?

Asse 3 — Evolutivo: regressioni, fissazioni e linee di sviluppo

Sul piano psichico, accanto alle forze di sviluppo progressivo esistono forze **regressive**. Le tendenze regressive si manifestano in corrispondenza di tutti i risultati importanti raggiunti dal bambino — come se il bambino avesse bisogno di tornare al sicuro prima di andare avanti. La regressione si organizza intorno a **punti di fissazione**. Ritorni occasionali a comportamenti più infantili sono normali.

Linee evolutive del bambino: - Da dipendenza → autonomia affettiva - Da assenza di controllo → pieno controllo sfinterico - Da egocentrismo → socievolezza - Da gioco autoerotico → oggetto transizionale → gioco simbolico

Compiti evolutivi dell'adolescente: - Mentalizzazione del sé corporeo - Separazione-individuazione - Formazione di valori - Nascita sociale

Fenomeni che sembrano patologici ma possono essere processi evolutivi normali: - Un certo livello di **dismorfofobia** all'adolescenza (il corpo si trasforma e può essere percepito come "strano") - **Condotte a rischio** adolescenziali (il cervello adolescente ha un'appetenza per eccitazione e ricompensa — ha un significato evolutivo preciso) - **Fobie specifiche** nei processi maturativi (intorno ai 2 anni nascono potenti capacità immaginative, e con loro arrivano le paure irrazionali) - **Ossessioni circoscritte** (collezionismo, ordine) nella fase di latenza — possono nascere, tramontare, e sostenere il bambino in quel momento

Asse 4 — Ambientale/Contestuale

Il bambino nasce, cresce e si sviluppa all'interno di una famiglia e da essa è influenzato. Il sintomo può essere il risultato del sistema di interdipendenza individuo-ambiente.

La valutazione deve considerare tre livelli (sistema ecologico): - **Microsistema:** esperienza diretta — funzionamento familiare, caratteristiche dei genitori, qualità della relazione adulto-bambino, fantasie del genitore sul disturbo del figlio - **Mesosistema:** contesti in cui il bambino non è coinvolto ma che influenzano il suo funzionamento (es. relazione tra scuola e famiglia) - **Macrosistema:** cultura di riferimento, valori, norme sociali

Il caso James: un fil rouge attraverso tutta la lezione

James è il caso clinico usato per mostrare come i quattro assi funzionano in pratica.

Presentazione: la madre chiama il Servizio medico psicologico. James non ascolta, picchia altri bambini, urla, scappa, ha difficoltà del sonno con incubi (parla di "un signore che fa paura"), mangia solo pasta in bianco.

Anamnesi: gravidanza non cercata da genitori giovanissimi (madre 17 anni, padre 16). Parto cesareo d'urgenza, small for date (1880g, 43 cm). Sviluppo perinatale e motorio nella norma, linguaggio apparentemente adeguato.

Asse sintomatico → sonno disturbato, autoregolazione deficitaria, comportamenti aggressivi, quota ansiosa → ipotesi: disturbo misto del comportamento e della sfera emozionale? Spettro autistico?

Asse strutturale (griglia Palacio Espasa): - Sguardo sfuggente, espressione triste/quasi assente; gioco simbolico espressivo; si separa dalla madre con indifferenza - Relazione con esaminatore: evitante poi più caldo; richiama l'attenzione ripetendo "guarda" - Linguaggio con ripetitività lessicali; pensiero discontinuo; esame di realtà conservato - Affetti negativi, tono dell'umore deflesso;

inibizione con possibili esplosioni di aggressività - Contenuti depressivi ("i cavalli muoiono, il bambino si ferisce"); immagine di sé centrata su bisogni primari di accudimento - Super-Io: rispetta i confini della consultazione, ha integrato regole di comportamento

Asse ambientale: contesto sociale sfavorito; famiglia senza struttura chiara ma con legame di mutuo aiuto madre-nonna; assenza del padre; scuola pubblica solida e accogliente; madre con ansia e lieve disturbo di personalità (quadro borderline compensato).

Diagnosi e indicazioni: - Disturbo misto delle emozioni e della condotta (ICD-10 F92.9) - Disturbo psichico del genitore (ICD-10 Z63.8) - Condizioni di fragilità psicosociale (ICD-10 Z59.1) - Intervento psicoeducativo a domicilio (SAE), lavoro di rete con SPS, psicoterapia orientata alla relazione madre-bambino

Come funziona la valutazione psicologica: il processo step by step

1. **Richiesta di consultazione**
 2. **Anamnesi** — storia del bambino, gravidanza, sviluppo, contesto familiare
 3. **Incontri:** colloqui con genitori, colloqui con il bambino/ragazzo, osservazione dell'interazione bambino-genitori, osservazione di gioco/disegno, eventualmente a scuola
 4. **Esami strumentali** (test psicometrici se necessari)
 5. **Riflessione** — integrazione di tutte le informazioni sui quattro assi
 6. **Restituzione** — descrizione profonda di un funzionamento unico (non solo etichetta diagnostica), gestione della ferita narcisistica del genitore trasformandola in opportunità di integrazione, proposta terapeutica
-

Concetti chiave

Termine	Significato
Sintomo	Manifestazione soggettiva; in psicoanalisi, compromesso tra pulsione e difesa. Nel bambino ha valore evolutivo.
Segno	Fenomeno oggettivo, misurabile dall'esterno
Norma statistica	Definizione di normalità basata sulla frequenza media; può diventare prescrittiva
Patognomonico	Sintomo univocamente associato a una sola malattia — in psichiatria quasi non esistono
Marker biologico	Sostanza organica che segnala un processo morboso — assente nella psicopatologia
Falso sé	Conformismo adattivo: assenza di sintomi come segnale di adattamento patologico
Punto di fissazione	Momento evolutivo dove il bambino si "blocca" in caso di regressione
Linee evolutive	Traiettorie di sviluppo su cui valutare il bambino (Anna Freud)
Anedonia	Assenza di interesse per attività normalmente piacevoli
Dismorfofobia	Percezione distorta del proprio corpo — può essere normale in adolescenza
Pruning	Potatura sinaptica neuronale — processo maturativo che ottimizza la connettività
Small for date	Nato con peso inferiore alle attese per l'età gestazionale

Domande di orientamento allo studio

Quali sono le quattro definizioni di normalità secondo Marcelli e quali sono i loro limiti? Marcelli (1999) identifica quattro definizioni: 1) Media statistica — normale è chi rientra nella media misurata; il limite è che è solo descrittiva e quantitativa, non dice nulla sulla sofferenza. 2) Ideale a cui avvicinarsi — normale è il bambino "perfetto" secondo le aspettative sociali; il limite è che dipende da chi definisce l'ideale. 3) Processo dinamico — normale è chi si adatta e torna all'equilibrio; il limite è che presuppone le stesse risorse per tutti. 4) Assenza di malattia — definizione circolare per esclusione. La norma statistica è la più usata clinicamente (strumenti come ADOS-2, WISC-V, CBCL), ma può diventare pericolosa se cristallizza una persona in un punteggio.

Cosa distingue il sintomo dalla patologia in età evolutiva? Il sintomo in sé non è il problema: in psicoanalisi è un compromesso tra pulsione e difesa, e rappresenta un tentativo di guarigione e di narrazione. Winnicott afferma che un bambino sano può manifestare un repertorio flessibile di sintomi — la loro assenza può essere un "falso sé". La patologia si manifesta come limitazione e rigidità: i sintomi non traghettano più il bambino oltre la difficoltà, diventano solo un disturbo. Il segnale patologico non è il sintomo in sé, ma la sua rigidità — quando il bambino non riesce a fare altro. I sintomi nelle fasi di transizione evolutiva meritano attenzione speciale perché spesso aiutano transitoriamente a organizzare l'affettività.

Quali sono i quattro assi della valutazione psicologica in età evolutiva? I quattro assi sono: 1) Sindromico-sintomatico — raccoglie e organizza i sintomi nelle aree del corpo (sonno, alimentazione, controllo sfinterico, motricità) e del comportamento (aggressività, affettività, linguaggio, cognizione). 2) Strutturale — va al di là dei sintomi e cerca l'organizzazione profonda del mondo psichico (nevrotica, borderline, psicotica) usando griglie come quelle di Bergeret, Kernberg, o Palacio Espasa/Dufour. 3) Evolutivo — valuta le forze progressive e regressive, i punti di fissazione, le linee evolutive del bambino e i compiti evolutivi dell'adolescente. 4) Ambientale/Contestuale — valuta microsystema (famiglia, relazione adulto-bambino), mesosistema (relazione famiglia-scuola) e macrosistema (cultura, norme sociali).

Cosa significa che in psichiatria non esistono sintomi patognomonici e perché questo complica la valutazione? Un sintomo patognomonico è un sintomo univocamente associato a una sola malattia — in psichiatria questi quasi non esistono. Lo stesso sintomo può indicare disturbi molto diversi: "non ho voglia di alzarmi dal letto" può essere clinofilia depressiva, disturbo del sonno o ritiro psicotico; le dispercezioni possono segnalare esordio psicotico, abuso di sostanze o disturbo del sonno. Questo rende necessaria una valutazione multiassiale che non si fermi ai sintomi ma consideri anche la struttura psichica, la linea evolutiva e il contesto. Un altro problema è che tendiamo a sovrastimare i sintomi "rumorosi" (aggressività, deliri circoscritti) e ignorare i sintomi silenziosi (calo delle funzioni cognitive, diminuzione della spinta vitale), che possono essere segnali di psicosi a esordio insidioso.

Come si legge il caso clinico di James attraverso i quattro assi? James, 4-5 anni: comportamenti aggressivi, disturbi del sonno con incubi, alimentazione selettiva. Asse sintomatico: autoregolazione deficitaria, quota ansiosa, ipotesi di disturbo misto del comportamento e sfera emozionale. Asse strutturale (griglia Palacio Espasa): gioco simbolico espressivo ma sguardo sfuggente, pensiero discontinuo, affetti negativi, contenuti depressivi (cavalli che muoiono), immagine di sé centrata su bisogni primari di accudimento. Asse evolutivo: sviluppo perinatale e motorio nella norma. Asse ambientale: contesto sociale sfavorito, genitori giovanissimi, assenza del padre, madre con ansia e tratti borderline compensati. La diagnosi finale integra disturbo misto delle emozioni e condotta, disturbo psichico del genitore e fragilità psicosociale — con un piano di intervento multilivello.

Collegamenti

Lezioni precedenti: - Le linee evolutive di Anna Freud e i compiti evolutivi dell'adolescente si collegano alle lezioni introduttive sul ciclo di vita - Il caso James richiama i temi dell'attaccamento: separazione con indifferenza, difficoltà di regolazione emotiva

Autori citati: - Marcelli (1996) — quattro definizioni di normalità - Winnicott — sintomo come espressione evolutiva - Bergeret (1974) — diagnosi strutturale - Kernberg (1984) — criteri formali per diagnosi strutturale - Palacio Espasa e Dufour

— griglia strutturale per età evolutiva - Anna Freud (1969, 2003) — *Normalità e patologia del bambino*, linee evolutive

Temi aperti / da approfondire: - Quando il confine tra processo evolutivo normale e patologia diventa clinicamente rilevante - Il ruolo della famiglia nella genesi e nel mantenimento dei sintomi - Come si gestisce la restituzione diagnostica con famiglie in difficoltà